# Antibiothérapie des infections de prothèses vasculaires (IPV)

Mise au point réalisée par le comité des référentiels de la SPILF
le 22 mai 2019

# Références

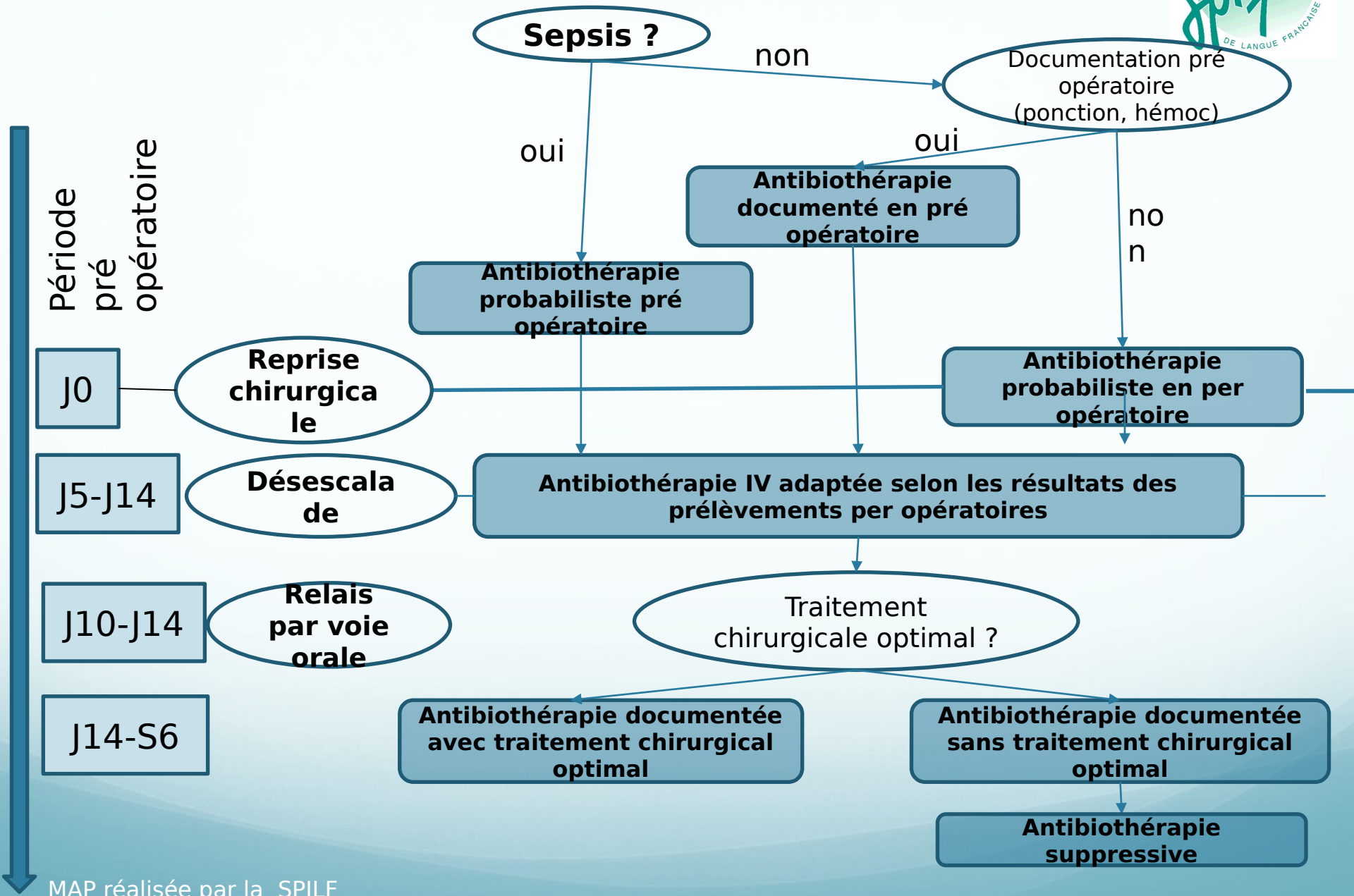

- M. Revest, F. Camou, E. Senneville, J. Caillon, Frédéric Laurent, Brigitte Calvet, P. Feugier, M. Batt, C Chidiac, pour le Groupe de Réflexion sur les Infections de Prothèses vasculaires (GRIP). Medical treatment of prosthetic vascular graft infections: Review of the literature and proposals of a Working Group. Intern J Antimicrob Agents 2015 ; 46 : 254-265

- Wilson WR, Bower TC, Creager MA, Amin-Hanjani S, O'Gara PT, Lockhart PB et al. Vascular Graft Infections, Mycotic Aneurysms, and Endovascular Infections: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2016 ;15;134 : e412-e460

# Généralités

- Prise en charge par une équipe multidisciplinaire
- Indications chirurgicales selon la classification de Samson
- Faible niveau de preuve en l'absence d'essai randomisé contrôlé
- Antibiothérapie extrapolée de la prise en charge des endocardites sur valves prothétiques et des infections osteo-articulaires sur matériel
- Ne pas débuter d'antibiothérapie en l'absence de sepsis ou de documentation fiable
- Réaliser au minimum 2 paires d'hémocultures avant le début de l'antibiothérapie

# Antibiothérapie des IPV




MAP réalisée par la SPILF

# Période pré-opératoire

- La prise en charge chirurgicale doit être la plus précoce possible après le diagnostic d'infection de prothèse vasculaire
- Si sepsis *: ATB probabiliste débutée en urgence **ET** intervention chirurgicale au plus tard dans les 48 heures
- Absence de sepsis **ET** documentation microbiologique pré opératoire : ATB adaptée **ET** intervention chirurgicale au plus tard dans les 7 jours

* Selon nouvelle définition

# Antibiothérapie probabiliste pré opératoire

# Antibiothérapie probabiliste pré opératoire

- Indication : IPV non documentée **ET** existence d'un sepsis *
- Spectre incluant systématiquement :
  - BGN (dont BLSE si antécédents de colonisation ou infection)
  - *Pseudomonas aeruginosa*
  - *Staphyloccocus (*dont SARM)
  - Anaérobies stricts
- L'intervention chirurgicale doit être réalisée le plus vite possible et au mieux dans les 48 h

* Selon nouvelle définition

# Antibiothérapie probabiliste pré opératoire

| Antibiotique | Dosage et voie | Commentaires |
|---|---|---|
| ***Sepsis avec ou sans colonisation ni infection à BGN résistant aux C3G connues dans les 3 mois<br>OU<br>Choc Septique sans colonisation ni infection à BGN résistant aux C3G connues dans les 3 mois*** | | |
| Pipéracilline-tazobactam<br><br>**Ou**<br><br>Cefepime plus<br><br>Métronidazole<br><br>**AVEC**<br>Daptomycine<br><br>**ET**<br><br>Amikacine | 200 mg/kg/j en perfusion prolongée ou continue après 4 g de dose de charge. Maximum16g/j<br><br>2gx3/j en perfusion prolongée ou continue après 2 g de dose de charge<br>500mgx3/j IV ou PO<br><br>10 mg/kg/j, IV une fois par jour<br><br>30 mg/kg/j en 1 perfusion IVL 30’ | Si allergie pénicilline<br><br>Second choix<br>Vancomycine 40 mg/kg/j IV, en perfusion continue après dose de charge de 30mg/kg en 120mn |
| ***Choc septique ET colonisation connue ou antécédent d’infection BGN résistant aux C3G connu dans les 3 mois*** | | |
| Méropénème<br><br>**AVEC**<br>Daptomycine<br><br>**ET**<br><br>Amikacine | 100 mg/kg/j en 3 à 4 perfusions de 4h00<br><br>10 mg/kg/j, IV, une fois par jour<br><br>30 mg/kg/j en 1 perfusion IVL 30’ | Si allergie Bêtalactamine : avis d’expert<br><br>Second choix<br>Vancomycine 40 mg/kg/j IV, en perfusion continue après dose de charge de 30mg/kg en 120 mn |

# Antibiothérapie probabiliste per opératoire

# Antibiothérapie probabiliste per opératoire

- Indication : IPV non documentée en l'absence de sepsis *
- Principes :
  - Antibiothérapie large spectre couvrant les BGN dont *Pseudomonas*, SARM et anaérobies
  - Début de l'antibiothérapie en per opératoire une fois les prélèvements multiples réalisés
  - Poursuite jusqu'aux résultats définitifs des cultures avant adaptation.
  - Antibiotiques identiques aux prescriptions probabilistes pré opératoires, sans aminoside (dont l'indication est l'existence d'un sepsis *)

* Selon nouvelle définition

# Antibiothérapie documentée en post opératoire

# Antibiothérapie documentée en post opératoire

- Indication : IPV documentée en post opératoire après résultats définitifs des cultures (entre J5-J7)
- Principes :
  - Adaptation aux résultats microbiologiques
  - Optimisation PK/PD
  - Usage si possible des molécules actives dans le biofilm :
    - Rifampicine pour les staphylocoques
    - Fluoroquinolone pour les BGN

# Antibiothérapie documentée en post opératoire

Deux situations différentes en fonction de la chirurgie

- Intervention chirurgicale optimale :

Ablation des implants infectés, excision d'un abcès

  - Relais précoce par voie orale possible
  - Durée de traitement court

- Intervention chirurgicale non optimale :

Rétention des implants infectés

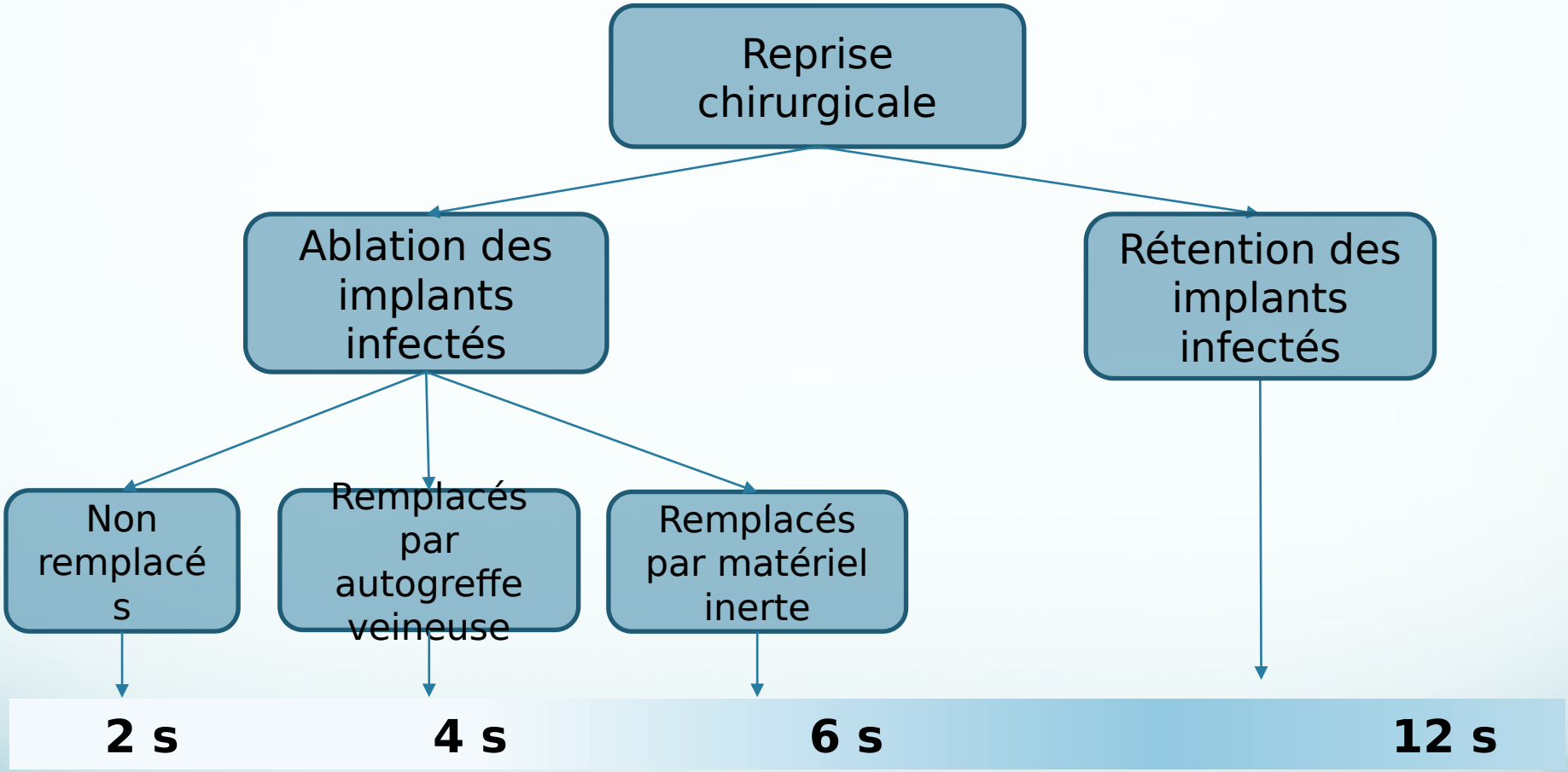
  - Durée de traitement prolongée
  - Antibiothérapie suppressive à discuter

# Cas particulier : infection à *Candida spp*

# Principes thérapeutiques

- Echinocandines I.V. indiquées en première intention pendant 10 jours
- Relais PO par fluconazole 800 mg dose de charge puis 400-800 mg/j si :
  - Souche sensible selon l'antifongigramme
  - Hémoculture négative depuis plus de 10 jours
  - Etat clinique stabilisé

# Durée de traitement



# Antibiothérapie suppressive

# Antibiothérapie suppressive

- Indications : IPV documentée microbiologiquement et incurable
  - en l'absence de chirurgie
  - chirurgie non-optimale : pas d'ablation complète du matériel
- Modalités:
  - Après diminution maximale de l'inoculum par lavage/drainage
  - Après 6 semaines d'antibiothérapie curative
  - Monothérapie PO : C1G, Cotrimoxazole, doxycycline
  - Décision après une discussion multidisciplinaire
  - Suivi du patient à M2 et M3 puis tous les 6 mois